

Wywiad *strukturalny*

Pełna ocena diagnostyczna bulimii — siedem obszarów. 60–90 minut. Podstawa dla planu CBT-E. Karta dla pacjenta — co przygotować przed sesją.

CZAS: 60–90 min · sesja diagnostyczna 1–2 Przed rozpoczęciem leczenia · raz, jako pomiar bazowy

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, CBT-E assessment); Cooper & Fairburn (1993, EDE)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **siedem obszarów** pełnego wywiadu diagnostycznego (sekcja 1), zobacz **cele każdego obszaru** (sekcja 2). W sekcji 3 — Twoje przygotowanie do sesji. Sekcja 4 — pytania, które chcę zadać.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pełny wywiad diagnostyczny bulimii to sesja 1–2 (łącznie 60–90 min). Zbiera informacje niezbędne do: **(A)** diagnozy formalnej (DSM-5/ICD-11), **(B)** konceptualizacji przypadku według modelu Fairburna, **(C)** decyzji o planie leczenia (CBT-E vs IPT-BN, ambulatoryjnie vs szpitalnie, farmakoterapia jako uzupełnienie), **(D)** oceny ryzyka somatycznego i psychiatrycznego. *Złoty standard: Eating Disorder Examination* (EDE 17.0, Cooper & Fairburn 1993) — pełny wywiad zajmuje 2–3 godziny. W praktyce klinicznej — skrócona wersja wywiadu strukturalnego pokrywająca **siedem kluczowych obszarów**: historia objawów, aktualny wzorzec, kompensacje, obraz ciała, trauma i czynniki ryzyka, współwystępowanie, motywacja i wsparcie. Karta pomaga *pacjentowi przygotować się* do sesji — przemyśleć obszary, których specjalista będzie pytał. Dobrze przygotowany wywiad *znacząco* skraca czas potrzebny na ustalenie planu leczenia i daje pełniejszy obraz.

01 = Siedem obszarów wywiadu

1 · HISTORIA OBJAWÓW

Kiedy się zaczęło, jak ewoluowało, co poprzedzało (dieta, trauma, zmiana życiowa). Wcześniejsze próby leczenia.

2 · AKTUALNY WZORZEC

Częstotliwość epizodów, typowy czas, miejsca, kontekst emocjonalny. Wzorzec dnia: śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, pomijane posiłki.

3 · KOMPENSACJE

Jakie, jak często, od kiedy. Wymioty, środki, ćwiczenia, głodówka. Czy zmieniał/-a się typ kompensacji w czasie.

4 · OBRAZ CIAŁA

Overvaluation wagi/kształtu. Ważenie, lustrowanie, unikanie. Schemat samooceny: jakie obszary życia tworzą Twoje poczucie wartości.

5 · TRAUMA · CZYNNIKI RYZYKA

Historia rodzinna ED, depresji, lęku. Trauma w dzieciństwie. Dietowanie wczesne. Komentarze rodziny o wadze. Środowisko sportowe.

6 · WSPÓŁWYSTĘPOWANIE

Depresja, lęk, OCD, BPD, używanie substancji, suicydalność. Ocena współistniejących zaburzeń wpływa na plan leczenia.

7 · MOTYWACJA I WSPARCIE

Co Cię skłoniło do szukania pomocy. Kto wie o problemie. Wsparcie rodziny, partnera, przyjaciół. Bariery (czas, finanse, stygma).

02 Cele każdego obszaru

Pytania w wywiadzie nie są *przesłuchaniem* — każdy obszar ma konkretny cel kliniczny. Zrozumienie celów pomaga Ci się zaangażować i dostarczyć użytecznych informacji.

DIAGNOZA FORMALNA

Czy spełniasz kryteria BN, BED, AN, OSFED.
Pozwala dopasować plan leczenia i zlecić odpowiednie skierowania (NFZ).

KONCEPTUALIZACJA

Twoja indywidualna mapa cyklu (model Fairburna).
Co napędza, co podtrzymuje, gdzie są punkty interwencji.

PLAN LECZENIA

Wybór formy (CBT-E, IPT-BN, FBT u młodzieży),
intensywności (ambulatoryjnie vs intensywnie),
współpraca z lekarzem.

OCENA RYZYKA

Somatyczna (hipokaliemia, arytmie)
i psychiatryczna (suicydalność, dekompensacja).
Decyzja o pilności i środowisku leczenia.

03 Moje przygotowanie do sesji

HISTORIA — KIEDY SIĘ ZACZEŁO, CO POPRZEDZAŁO

— wiek początku, kontekst życiowy, ewolucja

AKTUALNY OBRAZ — CZĘSTOTLIWOŚĆ, WZORZEC

— epizody, kompensacje, typowy dzień; bez ocen, tylko fakty

04 Pytania, które chcę zadać

CO CHCĘ WIEDZIEĆ OD SPECJALISTY

— diagnoza, plan, czas trwania, oczekiwania, koszt; cokolwiek niepokoi

Klucz: wywiad diagnostyczny *nie* jest „przesłuchaniem” ani „oceną moralną” — to **narzędzie kliniczne**, które pomaga zbudować *indywidualny plan* leczenia. Dobrze przygotowany pacjent skraca czas potrzebny na conceptualizację i daje pełniejszy obraz. **Wstyd** jest naturalną reakcją, ale często prowadzi do ukrywania ważnych informacji — to działa *przeciwko* leczeniu. Specjalista, który prowadzi wywiad ED, *nie jest zaskakiwany* żadnym objawem ani zachowaniem — w jego pracy widział wszystko. Twoja otwartość **chroni** Cię — pełen obraz pozwala zaplanować właściwą interwencję. Fairburn (2008): w CBT-E sesja diagnostyczna kończy się *wspólną* conceptualizacją (rysowanie modelu cyklu na podstawie Twoich danych) — to ważny moment terapeutyczny, bo widzisz, że Twoja sytuacja *ma sens*, nie jest „chaosem”. Ten moment jest często **punktem zwrotnym** motywacji.